

ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΛΚΟΟΛ ΤΡΟΜΩΔΕΣ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

Γενικά: Το σύνδρομο στέρησης χαρακτηρίζονται από σημεία και συμπτώματα που είναι το φυσιολογικό αντίθετο των φαρμακολογικών δράσεων του φαρμάκου στο οποίο είναι εθισμένος ο ασθενής (χρήστης). Τα συμπτώματα μετά από διακοπή φαρμάκων με βραχεία διάρκεια δράσης, όπως το οινόπνευμα, μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε 8 έως 24 ώρες από τη διακοπή της λήψης αλκοόλ και υποχωρούν κατά κανόνα μέσα σε 24 με 48 ώρες.

Ο άμεσος στόχος της προφύλαξης και της θεραπείας του συνδρόμου στέρησης είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως **τρομώδες παραλήρημα**, επιληπτικές κρίσεις και μείζονες βλάβες από το καρδιαγγειακό σύστημα, που προκαλούνται ως τελικό αποτέλεσμα της έντονης συμπαθητικής εκφόρτισης.

Το τρομώδες παραλήρημα αποτελεί μια εξόχως σοβαρή και επείγουσα κατάσταση, που εμφανίζεται εντός μιας εβδομάδας (συνήθως τη 2^η ή 3^η ημέρα) από την τελευταία λήψη οινόπνευματος και μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο εβδομάδες (συνήθως διαρκεί 2-5 ημέρες). Χρειάζονται συνήθως 5-15 χρόνια κατάχρησης αλκοόλ για να εμφανισθεί το σύνδρομο.

Κλινική εικόνα: Τα κύρια συμπτώματα και σημεία του στερητικού συνδρόμου, είναι:

- Έντονες παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις (κυρίως οπτικές ή απτικές που συχνά αφορούν ζώα ή έντομα, ενίοτε και ακουστικές, αλλά και παρερμηνείες).
- Παραληρητικές ιδέες (καταδίωξης, συνωμοσίας, ενοχής, υποχονδρίας, μεγαλείου κ.ά.).
- Αποπροσανατολισμός, θόλωση της συνείδησης.
- Αυξημένη (ή μερικές φορές κι ελαττωμένη) ψυχοκινητική δραστηριότητα.
- Κρίσεις γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών.
- Ασυνάρτητη ομιλία,
- Υπερδραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος - ΑΝΣ (αρτηριακή υπέρταση, ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, υπερθερμία, εφίδρωση, έξηση, μυδρίαση, κ.ά.),
- Ανορεξία, ναυτία, έμετος, διάρροια, αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Ο ασθενής που προσέρχεται σε συγχυτικο-διεγερτική κατάσταση (Delirium tremens), απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, με ιδιαίτερη προσοχή, ψυχραιμία και ενίοτε «διπλωματία», χωρίς επικριτική στάση από μέρους μας και χωρίς να επιτείνουμε τη διέγερσή του.

Πρέπει, πάντοτε, να θυμόμαστε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ασθενής να εμφανίσει παρατεινόμενη επιληπτική προσβολή (status epilepticus), λόγω της απότομης διακοπής του αλκοόλ ή των συνοδών τραυματικών κακώσεων της κεφαλής από πτώση επί του εδάφους. Οι επιληπτικές προσβολές του συνδρόμου απόσυρσης είναι γενικευμένοι τονικοκλονικοί σπασμοί, οι οποίοι εκδηλώνονται εντός των πρώτων 48 ωρών της αποχής από το αλκοόλ.

Ιστορικό: Η λεπτομερής λήψη ιστορικού θα μας κατευθύνει εύστοχα στη διάγνωση.

Διαφορική διάγνωση: Η Δ/Δ περιλαμβάνει τα ακόλουθα: υποξία, σήψη, ουραιμία, ΑΕΕ, ηλεκτρολυτικές διαταραχές (υπονατριαιμία, υπασβεστιαίμια, υποφωσφαταιμία), επιληψία, κετοξέωση, μυξοίδημα, θυρεοτοξίκωση φαιοχρωμοκύττωμα, υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, ηπατική ανεπάρκεια, μεταβολική ή σηπτική εγκεφαλοπάθεια, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, σύνδρομο Wernicke, υποσκληρίδιο αιμάτωμα, εγκεφαλικό απόστημα, τοξίκωση από ουσίες (κοκαΐνη, ηρωίνη, PCP), σύνδρομο σεροτονίνης, στερητικό σύνδρομο βενζοδιαζεπινών.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Εξαιτίας της έντονης ψυχοκινητικής διέγερσης του ασθενούς, συνηθέστερα, η αρχική θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί ενδομυϊκώς και εν συνεχεία, και εφόσον ο ασθενής ηρεμήσει, μπορεί να επιχειρηθεί ενδοφλεβίως η δέουσα θεραπευτική αγωγή.
2. Τοποθετούνται δύο ευρείες (#16-18 G) 3-way φλεβικές γραμμές και χορηγούμε βραδέως διάλυμα 1000 ml D5W, μαζί με 2 amp. NaCl 0,9% και 1-2 amp. KCl.

3. Προσθέτουμε 1 amp. πολυβιταμινούχο διάλυμα **Soluvit** ή **Evaton** σε 500 ml NaCl 0,9% με σχετικώς ταχεία ροή. Σημειώνεται εδώ, ότι η χορήγηση θειαμίνης (vit. B₁) θεωρείται απαραίτητη προ της χορηγήσεως γλυκόζης για αποφυγή της εγκεφαλοπάθειας Wernicke, αλλά κυρίως για την αποφυγή πρόκλησης γαλακτικής οξέωσης, ενώ η θειαμίνη απαιτεί και την παρουσία μαγνησίου για να δράσει αποτελεσματικά, ιδίως σε χρόνιους αλκοολικούς.
4. Προσθέτουμε στον ορό 1 amp. Θεικό Μαγνήσιο (2 gr MgSO₄), για τις πρώτες 6 ώρες. Σκόπιμη κρίνεται η χορήγηση 1 gr MgSO₄ ανά 6-8 ώρες, για 2-3 ημέρες (στους ασθενείς που εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις μετά τη διακοπή της χρήσης οινόπνευματος).
5. Προσθέτουμε, επίσης, στον ορό **Διαζεπάμη** (2 amp. Stedon των 10 mg σε 500 ml N/S). Σε μια τυπική θεραπευτική αγωγή καθορισμένης δόσης, 10 mg δίνονται ενδοφλεβίως ή από το στόμα ανά 6 ώρες για 4 δόσεις, κατόπιν 5 mg δίδονται κάθε 6 ώρες για 8 δόσεις.
Δεσπόζοντα ρόλο στην παθοφυσιολογία του εν λόγω συνδρόμου φαίνεται να διαδραματίζει η ελάττωση των υποδοχέων του GABA (γ-αμινοβουτυρικού οξέος) στον εγκέφαλο, γεγονός που προκαλεί διέγερση. Έτσι, οι βενζοδιαζεπίνες (Χλωροδιαζεποξείδη - Oasil 15 mg, 1x4) φαίνεται πως κατέχουν σημαντική θέση στην αντιμετώπιση του συνδρόμου απόσυρσης από το αλκοόλ. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη χορήγηση κατασταλτικών φαρμάκων του ΚΝΣ, λόγω της υφιστάμενης έκπτωσης της ηπατικής λειτουργίας από τη χρόνια κατάχρηση αλκοόλ.
Για ασθενείς με σημαντική ηπατική δυσλειτουργία ή άτομα μεγάλης ηλικίας, φάρμακο εκλογής θεωρείται η **Λοραζεπάμη** [Tavor: tbs. 1 mg ή 2,5 mg (po) ή amp. 4 mg/ml (iv)], διότι παρουσιάζει μικρό χρόνο ημιζωής και δεν έχει ενεργούς μεταβολίτες.
6. Για ήπια καταστολή, χορηγούμε 1 amp. **Αλοπεριδόλη** (Aloperidin 1 mg/amp.) 1x1 (im), καθώς επίσης και 1 amp. **Βιπεριδένη** (Akineton 5 mg) 1x1 (im) (στην ίδια σύριγγα).
Η Αλοπεριδόλη, ισχυρός ανταγωνιστής της ντοπαμίνης, θεωρείται ως ένα ταχείας δράσεως νευροληπτικό, η οποία ανήκει στην ομάδα των βουτυροφαινονών και μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα του εκδηλωθέντος παραληρήματος, αλλά δεν αποτρέπει την εμφάνισή του.
7. Η **Κλονιδίνη** (κεντρικώς δρών α₂ αδρενεργικός αγωνιστής) μειώνει τις εκδηλώσεις από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ), αφού προκαλεί καταστολή του συμπαθητικού μειώνοντας τις κατεχολαμίνες στο πλάσμα και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από τη χορήγηση της βενζοδιαζεπίνης. Θεωρείται δε, ιδιαιτέρως χρήσιμη στους ασθενείς με στερητικό σύνδρομο που πάσχουν από αρτηριακή υπέρταση και στεφανιαία νόσο.
 - Έτσι, χορηγούμε Κλονιδίνη (1 amp. Catapresan 150 mg) ενδομυϊκώς ή προτιμότερο στάγδην ενδοφλεβίως, διαλυμένη σε 100 ml NaCl 0,9%, σε έγχυση 15-30 λεπτών.
Προσοχή χρειάζεται στις ανεπιθύμητες ενέργειες της Κλονιδίνης, όπως βραδυκαρδία, υπόταση, καταστολή του ΚΝΣ, σύγχυση, τρόμο, υποθερμία, άπνοια. Ως αντίδοτο, στην καταστολή του ΚΝΣ και στην άπνοια από Κλονιδίνη, χορηγούμε 1-3 amp. Ναλοξόνη (Narcan) iv-bolus, ενώ για τη βελτίωση των αιμοδυναμικών παραμέτρων του ασθενούς χορηγούμε ντοπαμίνη ή νορ-αδρεναλίνη, πάντα με τον ασθενή σε ΗΚΓφικό monitoring.
8. Στους ασθενείς με εξεσημασμένη υπέρταση, ταχυκαρδία ή ταχυαρρυθμίες και με έντονα συμπτώματα από το ΑΝΣ, χορηγούμε (παράλληλα ή αντί της Κλονιδίνης), ενδοφλεβίως, 5 mg **Μετοπρολόλη** εντός 10-30 λεπτών (ήτοι: 1 amp. των 5 mg σε 100 ml NaCl 0,9%) ή αλλιώς ¼ ή ½ tab. Lopresor 100 mg (po), με συχνό έλεγχο ΑΠ και καρδιακού ρυθμού.
9. Χορηγούμε στον ασθενή μας συμπλέγματα βιταμινών, συστηματικά, για 15-30 ημέρες, amp. Neurobion (B₁, B₆, B₁₂) 1x2 (im), καθώς και Φυλλικό οξύ (tab. Filicine 5 mg, 1x1) και συμπληρωματικά πόσιμο Μαγνήσιο (Trofocard/Mag-2/Orbimag, σε δόση 1x1).
10. Στην περίπτωση μη βελτίωσης ή/και επιδείνωσης της οξείας κατάστασης, διακομίζουμε στο νοσοκομείο, για περαιτέρω παθολογική και ψυχιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση.

Προσοχή: Η χορήγηση οινόπνευματος για την προφύλαξη από την εμφάνιση του συνδρόμου στέρησης δεν θεωρείται πλέον αποδεκτή πρακτική. Η χορήγηση οινόπνευματος (ακόμα και στον ελεγχόμενο χώρο ενός ΤΕΠ και υπό ιατρική επίβλεψη) μπορεί να εμποδίσει μεν την εμφάνιση ορισμένων από τα συμπτώματα απόσυρσης του αυτόνομου νευρικού συστήματος (π.χ. υπέρταση, εφίδρωση, ταχυκαρδία, κ.λπ.), αλλά χαμηλώνει τον ουδό για την εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων.

